جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : صفاء لطفي امام محمد
المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** قليوب **العنوان :** قليوب
رقم البطاقة : 27208061401701 **رقم التليفون :** 01114405558 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 06-08-1972 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: صفاء لطفي امام محمد
National ID: 27208061401701

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



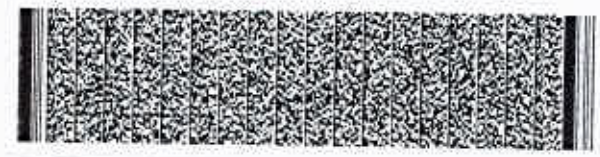
٢٧٢٠٨٠٦١٤٠١٧٠١ ٢٠٢٤/١٠

حاصله على دبلوم تمريض

أنثى مسلمة متزوجة

سامح محمد محمد فرج

١١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١٠/١١





National ID - Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: صفاء لطفي امام **MR. :** 2021	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient is a 54-year-old individual who was perimenopausal at the time of diagnosis. A positive family history for breast cancer is noted. Relevant comorbidities include hypertension and cardiac disease managed with aspirin.

Core needle biopsy confirmed invasive lobular carcinoma (ILC). Immunohistochemistry demonstrated strong hormone-receptor positivity with ER 8/8 and PR 8/8, HER2 negative, and a Ki-67 proliferative index of 12 %. The surgical pathology from the upfront left modified radical mastectomy performed in September 2022 described a pT3N0, grade 2 ILC measuring 7 × 5 × 2 cm, with inconspicuous lymphatic tumor emboli and positive perineural invasion. Adjuvant chemotherapy with docetaxel plus carboplatin was administered for four cycles, followed by completion of adjuvant radiotherapy. No metastatic work-up findings are reported.

The referring team recommended consideration of switching the current hormonal therapy, tamoxifen initiated in February 2023, to an aromatase inhibitor. The multidisciplinary team reviewed the case and agreed to proceed with the proposed shift to an aromatase inhibitor as the next line of hormonal treatment.

تحريرا في ,

التاريخ :	**23-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج :

يعتمد ,

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECIION SUPPORT

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

تاريخ الاصدار :2-1-2023 جهه الاصدار :فرع القليوبية

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التامينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) صفاء لطفى امام بطاقة رقم 27208061401701

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى
وشكرا

تاريخ الطباعه :2-1-2023

الموظف المختص

سليمان عبد الله

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد

مسلسل 301384

يعتبر هذا الخطاب ساري لمدة شهر من تاريخ الاصدار

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
إدارة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Safaa Lotefy Emam Mohamed	Date : 18/10/2022
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 50 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 18652

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Left MRM with opetaive bed scarring and small seroma.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- Enlarged liver with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Low lying malrotated pelvic right kidnesy. Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Reviewed skeleton showed:
  - Bilateral sacroilitis.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

MDT FORM 5/9/2021 GC

Name	[illegible]	MRN	C-CC/[illegible]
		ID	CK·M·[illegible]
Age	[illegible] 50	Phone	0114470 5559
Menopausal status		marital status	
NRS SCORE		Family history	+ve FH
BMI		REASON OF MDT	
Co morbidity	HTN → Nimbb. XOM	Cardiac on Aspirin 1mg.	

Clinical Data

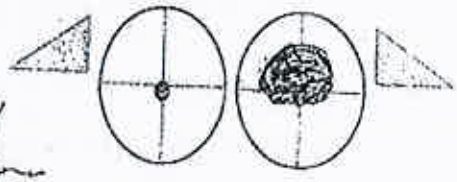
Bx:

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:

Sonomammography : Retro-areolar asymmetry Distortion hypoechoic lesion BIRADS 4c

Mets Workup:

R L



TNM

Recommendations: Large Lt Breast mass & nipple retraction, 2 Biopsies were Taken, Atypical ductal hyperplasia for MDT

MDT OUTCOME & PLAN In view of being clinically highly suspicious, consenting patient for MRM.
Procedure : WLE + FS
- Benign / wait for paraffin : closure without reconstruction.
- Malignant / Mastectomy + SLNB + delayed reconstruction.

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	psychiatric
[signature]	[signature]	[signature]			

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذه / صفاء لطفى امام محمد	Request No.	: 13003636
Patient No.	: 27208061401701	Request Date	: 27/06/2022
Path No.	: 1608/2022	Verification Date	: 18/07/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - ثقة الدولة
Age	: 49 Y	Department	: Out Patient
Refereing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast mass

Nature of the specimen:
Tru-Cut biopsy

Gross Examination:
Fragmented and hemorrhagic greyish white tissue cores, up to 0.5x0.5cm collectively.
Totally submitted.

Microscopic examination:
- Histological type: Atypical ductal hyperplasia.
- Angioinvasion: No
- Additional pathologic findings: No

Diagnosis:
Left breast mass; Tru-Cut biopsy:
-Atypical ductal hyperplasia. Rebiopsy is recommended to rule-out invasive cancer.

Prof. Dr. Iman Gouda
Dr. Abdulrahman Ibrahim

عبد الرحمن ابراهيم
01/08

Verified by :
abdelrahman ibrahim

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / صفاء لطفى امام محمد	Request No.	: 13002191
Patient No.	: 2720861401701	Request Date	: 04/08/2022
Path No.	: 2193/22	Verification Date	: 24/08/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 49 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: dr.Enas

Pathology Report

CLINICAL DATA : Left breast mass
NATURE OF SPECIMEN
Tru cut biopsy, collected at 4/8/2022 , 9:30 am

GROSS EXAMINATION
Multiple grayish white tissue cores up to 2 cm , totally submitted.

MICROSCOPIC EXAMINATION
Microscopic examination revealed marked fibrosis with focal atypical ductal cell proliferation.

DIAGNOSIS
Left breast mass , Tru cut biopsy:
Marked fibrosis with focal atypical ductal cell proliferation .
Larger biopsy or excision is recommended to rule out malignancy.

Signature
Prof. Dr. Iman Gouda
Dr.Samah Sayed

Verified by :
saamah sayed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / صفاء لطفى امام محمد	Request No.	: 13001822
Patient No.	: 27208061401701	Request Date	: 10/09/2022
Path No.	: 2671/22	Verification Date	: 18/09/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 50 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Lymph node involvement: no (0/5)
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: N/A
- Additional pathologic findings:N/A

Diagnosis:
Left breast cancer, Left simple mastectomy & SLNs;
Invasive lobular carcinoma, Grade II
Free resection margins.
Inconspicuous lymphatic tumor emboli
Positive Perineural invasion
Free Nipple & areola
Free sentinel lymph nodes (0/5)
Stage: pT3 pN0

Prof. Lobna Omar

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / صفاء لطفى امام محمد	Request No.	: 13001822
Patient No.	: 27208061401701	Request Date	: 10/09/2022
Path No.	: 2671/22	Verification Date	: 18/09/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 50 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast cancer

Nature of the specimen:
Left simple mastectomy & SLNs

Gross Examination:
Five specimens were received submitted as:
1-Sector of mammry tissue measuring 13x7x4 cm. Cut section revealed an ill-defined firm grsyish white mass measuring 7x5x2 cm, located 0.2 cm from least resection margin (medial)
2- Extra-superior margin: Fibrofatty tissue; 4.5x4 cm. grossly unremarkable
3- Extra-medial margin: Fibrofatty tissue; 8x4 cm, grossly unremarkable
4- Sentinel lymph node: Fibrofatty tissue; 3x3 cm, entangling five nodules ranging in size from 0.5 cm to 1.5 cm.
5- Simple mastectomy; 19x8x3 cm, covered by skin ellipse;20x6 cm. Nipple& areola was unremarkable grossly
• Frozen section: Invasive lobular carcinoma & Free sentinel lymph nodes (0/5)

Microscopic examination:
• Histological type: Invasive lobular carcinoma, GII (Classic & tubulo-lobular varians)
• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
• Angioinvasion: No
- Positive perineural invasion
• Lobular in situ: yes
• Tumor extent
o Number: 1
o Size: 7x5x2 cm
o Skin involvement: No

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Safaa Lotefy Emam Mohamed	Date : 30/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 51 Year(s)
Medical ID: 3341/2022	

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C),
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly ,

Dr/Asmaa Zeinhom, Msc

Not Approved

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Safaa Lotefy Emam Mohamed	Date : 01/02/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 3341/2022	Pat. ID: 18652

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Right UOQ stationary macrocalcifications
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Yasmin Nada

01/02/2025 11:49 AM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]